Osztálykód: 01E810103
Általános Belgyógyászat
Vezető.: Lengyel Zoltán PhD
Beosztás: osztályvezető főorvos
Telefon: 06-1/430-4800 /1291
Email: belgyogy@sztmargit.hu

BUDAPESTI
SZENT MARGIT
KÓRHÁZ

BUDAPESTI
SZENT MARGIT
KÓRHÁZ
1032 Budapest, Bécsi út 132.
Telefon: +36 - 1 - 430 - 4800
Fax: +36 - 1 - 439 - 0276
www.szentmargitkorhaz.hu

Zárójelentés

		Törzsszám:	**2026012731**
Beteg neve:	**Ökrös Julianna**	**TAJ száma:**	**081 730 038**
Anyja neve:	Bedécs Julianna	Születési ideje:	1975.01.07.
Lakcíme:	1039 Budapest Lukács György utca 23. 4/11.		
Felvétel ideje:	2026.10.01. 12:12	Térítési kategória:	magyar biztositás alapján végzett térítésmentes ellátás
Távozás ideje:	2026.10.08 15:00	Felvétel típusa:	sürgős ellátás, önkéntes - a beteg saját kérésére
Beteg további sorsa:	Otthonába bocsátva		

Anamnézis:
- 2005 óta ismert 2-es tip.cukorbetegség. Évek óta inzulinnal kezelt.
- 2023.10: Sebészeten jobb II.lábujj amputatio gangraena miatt.
Diétát nem tart, jelentősen csökk compliance
- 2026.08: diab kontroll rendelőben. 26-22-22E Apidra és 50E Toujeo, 1x600 mgThiogamma.
per os antidiebtikumokat jelenleg nem szed. korábban szedett Xigduot.

Jelen
A beteget családorvos utalja felvételre, saját lábán érkezik otthonából.
Hetek óta terhelésre fullad, korábban köhögött lázas volt. Mellkas rtg pneumoniat igazotl területen. Kombinált antibiotikus kezelés (azitromycin és augmentin) mellett láza csökkent, de fulladás terhelésre nem. Fentiek miatt küldi be CT vizsgálatra.
Érkezésekor terhelésre fullad, de nyugalomban fekve nem, körlevegőn kiválóan szaturál, oxigenigénye nincs, nem dohányzik. Utóbbi időben sokat hizott. 120 kgról jelenleg 130 kg. (163 cm). Hasa, lába is oedemas. Mellkasi fájdalma nincs, EV nem volt, hasa bélés, nem fáj, de alhas bőre induráltan oedemas. Széklete rendben nem volt sem fekete sem véres. UM pontos ideje nem ismert. Nőgyógy rendellenes vérzés nincs. dysuria és haematuria nem volt. Lábain található sebek miatt sebészeten járt már korábban.

Gyógyszerei: 26-22-22E Apidra és 50E Toujeo sc. 1x600 mg Thiogamma. 10/2,5 mg Coverex AS komb forte, 2x2,5 mg Nebivolol, 2x5 mg Amlodipin, 1x100 mg ASA, 1x20 mg Atorva, 40 mg Emozul
CAVE nincs
Vért nem kapott. Nem dohányzik. Gyermeke nincs.

Felvételi státusz:

RR: 176/92j.k. Hgmm P: 98/min reg.et aeg.

130 kg, 163 cm. SpO2 96% körlevegőn
BMI: 49!

Kp. fejlett, igen kifejezetten obes beteg. Bőr, látható nyálkahártyák kp. vérteltek. Cyanosis, icterus nincs, oedemas boka, lábfej, vádli, és alhas bőres is. Sclera fehér, conjuktiva kp. erezett. Garatképletek békések,

fogazat pótolt. Nyelv nedves, nem bevont. Kóros nyirokcsomó nem tapintható. Pajzsmirigy mirigyes tapintatú. Külső genitáliák, mammák eltérés nélkül.

Mellkas:
Alakja részarányos. kp. állású, légzésre mko. jól kitérő rekesz. Pulmok felett t.é.n.d. kopogtatási hang, érdes sejtes alaplégzés hallható. zörej nincs

Szív:
Határai fent a III. bordaközben, jobb oldalon a sternum jobb széle, bal oldalon a medioclaviculáris vonalon belül 1 hujjal. Halk, ritmusos szívhangok, zörej nem hallható.

Has:
A mellkas szintje felett, puha, betapintható. Kóros resistencia, nyomásérzékenység nincs. Májtompulat megtartott, kp. intenzitású bélhangok hallhatók. Máj elérhető, lép nem tapintható. Vesetájak ütögetésre nem érzékenyek. köldök korül több keményebb csomó melybe inzulint adta korábban, helyenként sebes is beadás helye. emellett alhas bőre induráltan oedemas, tömött.

Mozgásszervek:
Jobb II lábujj amp. utáni állapota, jobb lábszáron féltenyérnyi pörkkel fedett seb, vádli lateralis részein is egy egy pár cm felüeltes nedvedző seb. oedemas lábfejek és vádlik, sebek körül a bőr hyperaemias is.

Perifériás erek:
Aa. carotis felett zörej nem hallható.Art. dors. pedis, art tibialis post. mko. nem tapintható.

Neurológia:
Külsérelmi nyom nincs. Tarkó szabad, meningeális izgalmi jelek nincsenek. Kerek, egyenlő, centrális, fényre, accomodatiora reagáló pupillák. Agyidegek eltérés nélkül. Felső- és alsóvégtagi sajtáreflexek egyenlők, megtartottak, kóros reflex nincs. Tudat tiszta, térben, időben, auto- és allopsychésen orientált.

EKG: sr. 98/min, PQ: 0,16s QRS: 0,08s bal tá., ST izoel, T poz.

Vizsgálati eredmények:

RR: 176/90-135/78-136/80-138/70-118/92 hgmm

130 kg felvételekor, elbocsátáskor 120 kg. kb 163 cm

2026.10.01. 14:39: CT diagnosztika, Dr. Hutóczki Csaba(O66205):
Mellkas natív+CTA vizsgálat: Natív mellkas sorozatot készítettünk a jugulumtól a mellékvesékig, majd pulmonalis fázisban készített iv. kontrasztanyagos (Omnipaque 350) sorozat a tüdőcsúcsoktól a sinusokig GE BrightSpeed CT berendezésen.
Mindkét tüdő légtartalma diszkréten fokozott, mindkét tüdő alsó lebenyében elszórtan egy-egy 2-7 mm-es, subpleuralis, residualis nodulus figyelhető meg.
Mindkét oldalon ábrázolódik kevés pleuralis folyadék, jobb oldali dominanciával. Jobb oldalon basalisan a pleuralis folyadék legnagyobb rétegvastagságú axiális síkban mérve 12 mm.
Pangásos kisvérkör figyelhető meg.
A mediastinumban néhány 8-13 mm nagyságú nyirokcsomó látható.
A pulmonalis törzsek kontrasztanyag telődése homogén.
A szív kissé nagyobb. A szív mögött, a hátsó - alsó mediastinumban 27 mm-es apró hiatus hernia figyelhető meg.
Az aorta normális tágasságú, lefutású.
Vélemény:

Kisfokú emphysema mindkét tüdőben.
Apró subpleuralis residualis nodulusok mindkét tüdő alsó lebenyében.

Kevés pleuralis folyadékgyülem mindkét oldalon, jobb oldali dominanciával.
Kisvérköri pangás.
Lymphadenomegalia mediastinalis.
Pulmonalis embolisatio nem igazolható.
Mérsékelt cardiomegalia.
Hiatus hernia.

2026.10.02. 11:50: Dietetika, Kovács-Vajda Edina(E00565):
Szóbeli dietetikai tanácsadásban részesült, írásbeli tájékoztató jegyzettel (diétás tájékoztató cukorbetegeknek), tápanyagtáblázattal, étrendi ötletekkel elláttam.

E.sz.:
Testsúlya: 130 kg, Testmagassága: 163 cm, BMI: 49
Testsúlya az elmúlt pár hónapban 10 kg-ot gyarapodott.
Napi 4-5x étkezik.
Időként cukros termékeket fogyaszt (pl. 3in1 kávé, kalács).
Uzsonnára kis étkezéseként 1 db zsemlét szokott fogyasztani.
Elmondása szerint nem tudta, hogy analóg inzulin terápia esetén 3x étkezés javasolt, így azt sem tudta, hogy kisétkezések esetén plusz inzulin adásra lenne szükség.
Otthonában délutáni, vacsora előtti vércukor értékei magasabbak általában.
Folyadék fogyasztása ~ 2-3 liter/nap, általában gyümölcs tea, ásványvíz, zero üdítő.
Diétás tanácsadásban többször részesült, diétát nem tart.
Compliane kérdéses.
Alapanyagcsere: 1933 kcal.

Javasolt diéta: napi 3x-i étkezés (analóg inzulin kezelés mellett), zsírszegény, meghatározott szénhidrát tartalmú, rostdús, krisztalloid szénhidrát mentes (kristálycukor, barnacukor, méz, juharszirup, stb) és folyadék bő étrend javasolt.

2026.10.05. 10:15: Gasztro és endoscop Szakamb., Dr. Kanyó Barbara Judit(O59380):

Oesophago-gastro-duodenoscopia

U9990	Sine morbo
16370	Oesophago-gastro-bulboscopia
88911	Felszíni érzéstelenítés
89442	Pulzoxymetria

Anamnesis: tisztelt endoscopia
kérnénk a beteg szives gastroscpoias vizsgálatát
anaemias, vashiányos.
inzulinnal kezelt DM, hxpertonias, obesizas
anaemia hátterében észlelhető e gastroscopia során eltérés?

Indikáció: anaemia kivizsgálása.
Eszköz: Olympus 2034916
Premedicatio: Lidocain spray
A vizsgálat időtartama: 5min
Antikoaguláns kezelés:- TAG kezelés: ASA 4 napja nem.
NSAID kezelés:-
Akadálytalan eszközlevezetés a szabályos endolumenű, ép nyálkahártya borítású nyelőcsőbe. A cardia csillag alakú jól zár. A Z-vonal a fogsortól kb. 40 cm eszközhosszra, ép. A gyomorban kp. mennyiségű éhgyomri secretum, a falak levegőbefúvásra jól tágulnak, a peristaltica végig halad. A cardiatáj, fornix retroversioban ép. A corpus nyálkahártya ép, a redőzet szabályos. Az angulus ép. Az antrum kerek, a nyálkahártya ép. A pylorus centrikus, zárt. A bulbus kerek, nyitott, a nyálkahártya ép. A postbulbaris szakasz, illetve a mélyduodenum ép, a Kerkring redőzet szabályos. A leszálló szárban epés bennék.
Biopszia: nem történt
Vélemény: Negatív felsőpanendoscopos kép.

2026.10.06. 09:00: Nőgyógyászati Szakrendelés, Dr. Mészáros Nándor Gábor(O98270):
Belgyógyászat küldi anaemia miatt.
P: nem volt.
UM: 2026 09 közepén
Betegség: DM, hpertonia, obesitas,

St: ép k. genit. szűk vag. portio folyt. rendes nagy uterus szabad környezetben.
Cyt. levéve: 247/E

TVS: 32×42mm uterus AVF ben, 2mm endometrium, bal old. ov. 27×27mm cystosus képlet látható tiszta bennékkel, jobb old. ov. nem hozható látótérbe. Douglasban szabad hasüri foly nem látható.
Vél: akut nőgyógyászati eltérést jelen vizsgálatunk alapján nem feltételezünk , teendő nincs.
Látta: Dr Doan

2026.10.06. 10:57: Központi Ultrahang Szakrendelés, Dr. Mikecz Ildikó(O46804):
Alkati okok miatt a vizsgálat korlátozott értékű.
A máj mérs. nagyobb, a jobb bordaívet kb. 2-3 h. ujjal haladja meg, reflektivitása megtartott, állományában focalis eltérés nem látható.
Az intra- és extrahepaticus epeutak nem tágabbak.
Az epehólyag átlagosan telt, nyakánál septalt, vékonyfalú, kőmentes.
A pancreas gázok által fedett.
A lép részben ábrázolható, nem nagyobb, áttekinthető részein homogén.
A vesék alakja, nagysága, szerkezete szabályos. Parenchyma vastagságuk átlagban 11 mm. A jobb vese üregrendszere jelzetten tágabb, pyelon 12x13 mm, kehelyszárak 4 mm-esek. A bal vese pyelonja szintén jelzett, 10x12 mm, a kehelyszárak nem tágabbak. Kőjel nem látható.
A retroperitonealis tér a kp. harmadban vizsgálható, itt körülírt kóros képlet nem ábrázolódik.
Az aorta normális tágasságú, kórjelző fali eltérés nem látható.
A hólyag kevéssé telt. Az uterus csak kis részében ábrázolható.
Bélgázosság.
A hasüregben szabad folyadék nem ábrázolódik.
A pleuraűrben folyadék egyik oldalon sem látható.
Vélemény:
Mérs. hepatomegalia.
Mindkét vese üregrendszere jelzetten tágabb.
Bélgázosság.

Labor eredmények:

2026.10.01.: [12:14] LDH: 430 U/l; GOT(ASAT): 41 U/l; GPT(ALAT): 76 U/l; Gamma GT: 110 U/l; Alkalikus foszfatáz: 120 U/l; CK: 109 U/l; CK-MB izoenzim: Emelkedett összCK esetén végezzük! U/l; Amiláz: 32 U/l; Glükóz : 10.8 mmol/l; Összbilirubin: 11.2 µmol/l; Összfehérje: 71.3 g/l; Albumin: 43.3 g/l; Karbamid: 4.5 mmol/l; Kreatinin: 70 µmol/l; eGFR-EPI: 86 ml/perc/1.73m2; Húgysav: 347 µmol/l; Nátrium: 135 mmol/l; Kálium: 4.2 mmol/l; Klorid: 100 mmol/l; Kálcium: 2.45 mmol/l; Magnézium: 0.75 mmol/l; Prokalcitonin: 35 mg/l alatti CRP esetén a vizsgálatot nem végezzük! ng/ml; CRP: 7.59 mg/l; Fehérvérsejtszám: 10.1 G/l; Neutrophil granulocyta: 7.57 G/l; Lymphocyta: 1.5 G/l; Monocyta: 0.87 G/l; Eosinophil: 0.07 G/l; Basophil: 0.07 G/l; Neutrophil %: 74.8 %; Lymphocyta %: 15.2 %; Monocyta %: 8.6 %; Eosinophil %: 0.7 %; Basophil %: 0.7 %; Vörösvértest szám: 4.04 T/l; Hemoglobin: 109 g/l; Hematokrit: 0.334 l/l; MCV: 82.5 fl; MCH: 27.0 pg; MCHC: 327 g/l; RDW-CV: 14.6 %; Trombocita szám: 340 G/l; Prothrombin idő: 14.0 sec.; INR: 1.12 ; D-Dimer: 0.26 µg/ml;
2026.10.02.: [07:58] Glükóz : 5.4 mmol/l; Anti-streptolizin O: 21 IU/mL; HbA1c : 9.2 %; HbA1c: 76.8 mmol/mol; Összkoleszterin: 3.8 mmol/l; HDL koleszterin: 1.42 mmol/l; LDL koleszterin: 2.09 mmol/l; Triglicerid: 1.19 mmol/l; Vas: 5.7 µmol/l; Transzferrin: 2.9 g/l; Transferrin szaturáció: 8 %; Ferritin: 24.0 µg/l; Süllyedés: 22 mm/h; Fehérvérsejtszám: 6.7 G/l; Neutrophil granulocyta: 4.42 G/l; Lymphocyta: 1.4 G/l; Monocyta: 0.68 G/l; Eosinophil: 0.08 G/l; Basophil: 0.05 G/l; Neutrophil %: 66.4 %; Lymphocyta %: 21.5 %; Monocyta %: 10.2 %; Eosinophil %: 1.2 %; Basophil %: 0.7 %; Vörösvértest szám: 3.88 T/l; Hemoglobin: 106 g/l; Hematokrit: 0.322 l/l; MCV: 82.8 fl; MCH: 27.3 pg; MCHC: 329 g/l; RDW-CV: 14.6 %; Trombocita szám: 314 G/l; Reticulocyta abszolút: 103.8 G/l; Reticulocyta %: 2.67 %; Vizelet fehérje: negatív ; Vizelet glükóz: negatív ; Vizelet aceton: negatív ; Vizelet urobilinogén: normál ; Vizelet bilirubin: negatív ; Vizelet hemoglobin: negatív ; Vizelet pH: 6.0 ; Vizelet fajsúly: 1.010 ; Vizelet üledék fehérvérsejt: 6 /látótér; Vizelet üledék vörösvérsejt: 1 /látótér; Vizelet üledék baktérium: 2 /látótér; Vizelet üledék laphámsejt: 13 /látótér; Vizelet mikroalbumin-kreatinin hányados /reggeli első vizelet: 4.99 mg/mmol; Vizelet mikroalbumin /reggeli első vizelet: 23.47 mg/l; Vizelet kreatinin /reggeli első vizelet: 4.7 mmol/l; B-12 vitamin: 347 pmol/l; Folsav: 25.02 nmol/l; TSH (szuperszenzitív): 2.241 mIU/l; [14:53] Laboratóriumi vércsoport meghatározás: "A" Rh(D) pozitív ; Osztályos vércsoport meghatározás: A Rh(D)pozitív ; Ellenanyagszűrés (LISS-Coombs): negatív ; Ellenanyagszűrés (papainos): negatív ; Direkt Coombs: negatív ;

2026.10.05.: [07:39] Weber előszűrés nem specifikus teszttel (1): negatív ;
2026.10.06.: [08:00] Nátrium: 137 mmol/l; Kálium: 4.9 mmol/l; Klorid: 99 mmol/l; Fehérvérsejtszám: 7.7 G/l; Neutrophil granulocyta: 5.21 G/l; Lymphocyta: 1.6 G/l; Monocyta: 0.69 G/l; Eosinophil: 0.12 G/l; Basophil: 0.08 G/l; Neutrophil %: 68.0 %; Lymphocyta %: 20.5 %; Monocyta %: 9.0 %; Eosinophil %: 1.6 %; Basophil %: 1.0 %; Vörösvértest szám: 4.38 T/l; Hemoglobin: 120 g/l; Hematokrit: 0.363 l/l; MCV: 82.8 fl; MCH: 27.4 pg; MCHC: 331 g/l; RDW-CV: 14.4 %; Trombocita szám: 383 G/l;

Diagnozis
Art.scler.univ.
Diabetes mellitus 1-es tipus
Hypertonia
Obesitas
Lymphoedema cruris l.u.
Hepatomegalia
Empyhsema pulmonum
Lymphadenomegalia mediast.
Insuff.ventr.utr.cordis
Anaemia vashiányos
Asthma bronchiale in obs.

Epikrizis
Az 51 éves beteg anamnézisében 20 éve fennálló 1-es tipusú cukorbetegség, hypertonia, obesitas, lymphoedema cruris, jobb II.lábujjamputatio szerepel. Rendszeres diabetológiai kontroll alatt áll. Compliance csökkent.
Jelenleg családorvosa utalta felvételre osztályunkra.
Hetek óta terhelésre fullad, korábban köhögött és lázas volt. Mellkas rtg pneumoniat igazolt területen. Kombinált antibiotikus kezelés (Azitromycin és Augmentin) mellett láza csökkent, de fulladás terhelésre nem. Fentiek miatt küldi be mellkas CT vizsgálatra. A beteg Tüdőgondozóban korábban nem járt. Érkezésekor terhelésre fullad, de nyugalomban fekve nem, körlevegőn kiválóan szaturál, oxigenigénye nincs, nem dohányzik. Utóbbi időben sokat hizott. 120 kg-ról jelenleg 130 kg l. (163 cm, BMI 49). Hasa, lába is oedemas. Mellkasi fájdalma nincs. Lábain található sebek és oedema miatt miatt sebészeten járt már korábban. Lymphoedema kezelését 2026.10.19-én kezdik területi rendelőben (Csobánka téren). Tüdeje felett kóros zörejt nem hallottunk. Mellkas CT sem tüdőemboliat sem pneumoniat nem igazolt. Pangás, emphysema, lymphadenomegalia, kevés kétoldali HTX került leírásra.
Parenteralis kombinált diuretikus kezelést, hörgtágítót alkalmaztunk, mucolitikum mellett. Beroduallal inhalált, Ventolint kapott. Oxigenre nem szorult. Súlya 10 kg-mal csökkent. Fulladásos panaszai megszűntek.
Laborban észlelt vashiányos anaemia miatt hasi UH, nőgyógyászati vizsgálat, gasroscopia történt, melyek során anamiat magyarázó eltérés nem igazolódott.
A beteget 2026.11.11-re colonoscopias (vastagbéltükrözésre) vizsgálatra előjegyeztük. 2026.11.10-én 9 órakor éhgyomorra (vizet ihat) osztályunkon felvételre jelentkezzen. Picoprep port (felhőbe receptre felirtam) hozza magával. Vizsgálat előtti héten rostmentesen étkezzen (húst keveset egyen, gyümölcsöt zöldséget ne egyen nyersen, leveseket, főzelékeket, burgonyát, könnyen emészthető ételeket egyen!)
Területi Tüdőgondozót CT lelettel és CD- vel keresse fel. (lelet és CD a betegnek kiadva)
Echocardiographias vizsgálatra 2026.11.10-re előjegyeztük. (osztályos felvétele napján lesz).
Panaszait obesitas mellett szívelégtelenség, tüdőemphysema, asthma okozhatta. Alsó végtag sebe mellé kissé hyperaemias területre Aluminium Aceticum tartaricum kenőcsöt kentünk (nem a sebbe).
A mai napon javult állapotban emittáljuk. **Inzulinok dózisát csökkentettük, cukra 4-8 mmol/l között mozgott, hypoglycaemiat nem észleltünk. Gondozó Diabetológusát is keresse fel!**

Javasolt
160g CH tartalmú diéta, 2000 kcal tartalmú étrend.
Napi 3 étkezés!
reggeli előtt 10E Apidra sc. 7 órakor
ebéd előtt 8E Apidra sc. 13 órakor

este 10E Apidra sc. **19 órakor**
22.00: 50E Toujeo sc.
1x600 mg Thiogamma
2x5/5 mg Covercard (amlodipin és perindopril)
2x2,5 mg Nebivolol
1x100 mg ASA (VASTAGBÉLTÜKRÖZÉS ELŐTT 1 HÉTTEL KORÁBBAN HAGYJA EL!)
1x20 mg Atorva
1x40 mg Emozul (esomeprazol)
reggel és délben 1-1 tabl Furon és 1x25 mg Spiron
1x1 t Kaldyum (ionkontroll rendszeresen javasolt!) 3 havonta legyen labor mindenképp!
2x1 t Magnézium biszglicinát
2x1 tasak Fluimucil (egy hétig szedje még)

Budapesti Szent Margit Kórház
Általános Belgyógyászati Osztály
1032 Budapest, Bécsi út 132.
NEAK kód: 01E8 10103

Budapest, 2026.10.07.

Dr. Lengyel Zoltán
PhD
osztályvezető főorvos aláírása

Dr. Brezina Zsuzsanna
főorvos
kezelő orvos aláírása

Dr. Brezina Zsuzsanna 572 ORVOS

Zárójelentését minden kontroll vizsgálat alkalmával hozza magával!

Nyilatkozat: Alulírott Ökrös Julianna 081730038 a mai napon a kórházi zárójelentést átvettem.

Budapest, 2026.10.07.

.....
beteg, vagy törvényes képviselőjének aláírása